



TAVI Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu

VAKALAR EŞLİĞİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ

TAVI

Günümüz gelişen tıbbi yöntemlerinden biri olan TAVI, hasta için konfor sağlamakla birlikte; cerrahiden daha az olsa bile bazı komplikasyonları da beraberinde getirmektedir.



HEDEF : Bu komplikasyonları iyi bir takım çalışması ile en aza indirmek ve minimum seviyede tutmaktır.





TARİHÇE

1992 yılında, Andersen ve ekibi stent bazlı domuz bioprotezleri denemişlerdir.

2002 yılında, Cribier ve ekibi tarafından ilk “TAVI” işlemi yapılmıştır.

Edwards SAPIEN ve Medtronic Core Valve’in Avrupa’da kabul edilmesiyle dünyada TAVI uygulanan hasta sayısı artmıştır.



TAVİ ENDİKASYONLARI

Semptomatik Kalsifik Aort Darlığı

Yüksek Cerrahi Risk

Cerrahi girişimin kontr-endike olması

80 yaş üzeri (son yıllarda)

Ek olarak

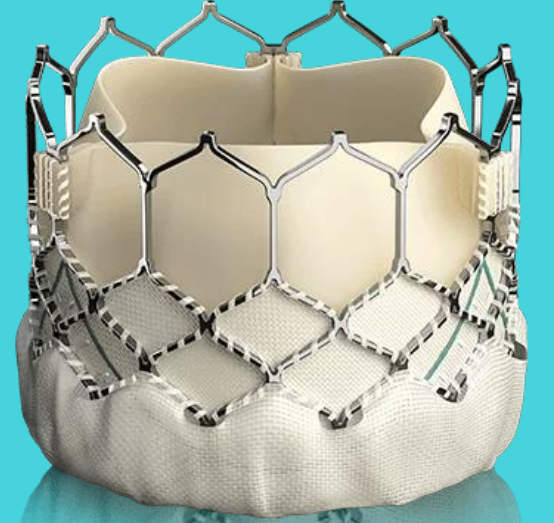
- ☐ Porselen Aorta
- ☐ Torasik Radyasyon Öyküsü
- ☐ Ciddi Torasik Deformite



İMPLANTASYON TEKNİKLERİ



Balon ile
geniřletilebilir
Edwards SAPIEN
(USA)



Kendiliğinden
geniřleyebilen
CoreValve
Revalving
(USA)



İMPLANTASYON TEKNİKLERİ







MONİTÖRİZASYON

- EKG
- PACİNG KABLOSU
- SANTRAL VENÖZ BASINÇ MONİTÖRİZASYONU
- PULSE OKSİMETRE
- İNVAZİV ARTERİYEL KAN BANSINCI
- TRANSKRANİYAL DOPPLER
- ISI
- SEREBRAL OKSİMETRE





TAVI UYGULAMA NOKTALARI

TRANSFEMORAL

TRANSAPİKAL

SUBKLAVİYAN





TAVİ İŞLEMİ



Vasküler ve torasik girişim

Kapak için kılavuz telin yerleştirilmesi, KPB için kateter takılması

Hızlı Ventriküler pacing testi

Nabızsız ventriküler taşikardi sağlamak için geçici pacemaker testi, Transtorasik ejeksiyonunun kısa süreli durdurulması

Hızlı ventriküler pacing altında balon valvüloplasti

Klasik aortik anülüsün dilatasyonu

Protez kapağın pozisyonlanması

Aortik anülüste transkateter kapağın pozisyonunun doğrulanması

Hızlı ventriküler pacing altında kapak yerleştirme

Aortik anülüste kapağın yerleştirilmesi



TAVİ İŞLEMİ

Kapak Yerleşimi





KOMPLİKASYONLAR



01

İŞLEM SIRASINDA OLUŞABİLECEK

02

GEÇ ZAMANDA OLUŞABİLECEK

01

İŞLEM SIRASINDA OLUŞABİLECEK

**Vasküler
Komplikasyonlar**

**Kapak
yerleştirmeye bağlı
Komplikasyonlar**

- Pozisyonel
- Anüler Rüptür

**Kapak
Fonksiyon
bozuklukları**

- Paravalvüler Leak

**Organ
Hasarları**

- Stroke
- MI
- ABY

Aritmi

Kalp Bloğu

**Düşük Kardiyak
Debi**

02

GEÇ ZAMANDA OLUŞABİLECEK

**Aortik
Regürjitasyon**

**Prostetik kapak
Trombozu**

**Periferik Akım
Bozukluğu**

- Paravalvular
Kaçak

**Kalıcı kalp pili
takılması**

**Enfektif
Endokardit**

İnme

Ölüm



İNME

Sebep:

- Aterom plağı
- Trombus
- Kalsiyum embolizasyonu



HEMŞİREDEN BEKLENTİLER

TAVİ sonrası bilinç kontrolü

Minimental test

Hasta yakınları ile iletişim

Akut değişim varlığında hekimin derhal uyarılması



AKUT MİYOKART ENFARKTÜSÜ



Protez Kapağın Koroner Arteri Tıkaması



Nativ Kapak Leafletlerinin Koroner Arteri Tıkaması



Balon Sonrası veya TAVI İşlemi Sırasında Koroner Arter Embolizasyonu



HEMŞİREDEN BEKLENTİLER

TAVI Sırasında ve sonrasında Monitör Kontrolü

ST Segment Elevasyonu

Göğüs Ağrısı Sorgulama

Hemodinamik Bozulma

Post TAVI KYBÜ da Telemetri

12 Derivasyonlu EKG



SONUÇ



Cerrahi riski yüksek



Inoperabl



Yaşlı popölasyon için

TAVI işlemleri ideal yöntemlerdir.



TEŞEKKÜRLER...

Semra AKTÜRK